

Fobie wg typu — *specyfika leczenia*

Pięć typów fobii według DSM-5. Każdy ma swój profil fizjologiczny i odmienny optymalny protokół leczenia.

CZAS PRACY: 15 min **KLASYFIKACJA:** DSM-5 (2013) **ŹRÓDŁO:** Choy i wsp. (2007); LeBeau i wsp. (2010)

JAK UŻYWAĆ

DSM-5 wyodrębnia **pięć typów** fobii specyficznej: zwierzęcą, naturalną (środowiskową), krew-zranienie-iniekcja (BII), sytuacyjną i inne (np. lęk dławienia, lęk wymiotów). Każdy typ ma odrębny profil fizjologiczny i wymaga *nieco innego* podejścia. Identyczny protokół dla wszystkich typów jest częstym błędem klinicznym.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Skuteczność leczenia zależy od dopasowania interwencji do typu. **Fobia zwierzęca** (pająki, węże, psy) reaguje najszybciej — często w 1–3 sesjach, bo bodziec jest ewolucyjnie „przygotowany” do szybkiej zmiany przez kontakt. **Fobia BII** wymaga technik *napinania mięśni* (Öst 1991), bo reakcja fizjologiczna jest dwufazowa (najpierw wzrost ciśnienia, potem spadek → omdlenie). **Fobie sytuacyjne** (latanie, klaustrofobia) są zwykle mieszanką kilku lęków — wymagają 4–8 sesji i częściej VR. **Emetofobia** (lęk wymiotów) jest najtrudniejsza i wymaga ekspozycji interoceptywnej (Sykes i wsp. 2015). Choy i wsp. (2007): rozróżnienie typów to nie kosmetyka diagnostyczna — to różnice rzędu 20–30% w skuteczności leczenia.

01 Pięć typów fobii — specyfika i pierwsza linia leczenia

TYP	PRZYKŁADY	SESJI ŚREDNIO	SPECYFICZNA INTERWENCJA
<i>Zwierzęca</i>	Pająki, węże, psy, ptaki, owady, gryzonie	1–3	Protokół jednej sesji (OST) + modelowanie przez terapeutę. Najszybsza reakcja na ekspozycję in vivo.
<i>Naturalna</i>	Wysokość, burza, woda, ciemność, wiatr	3–6	Ekspozycja in vivo (schody, balkony) lub VRET. Edukacja meteo dla fobii burzy.
<i>BII</i> (krew-rana-iniekcja)	Widok krwi, zastrzyki, pobranie, dentysta, zabiegi	5–8	Napinanie mięśni (Öst 1991) zamiast relaksacji. Bez tego — ryzyko omdlenia.
<i>Sytuacyjna</i>	Latanie, winda, tunele, mosty, klaustrofobia, MRI	4–8	Mieszanka lęków — multimodalne. VRET + in vivo. Czasem treningi specjalistyczne (Skyway).
<i>Inne</i>	Lęk wymiotów (emetofobia), dławienia, hałasu, kostiumów	6–12	Ekspozycja interoceptywna (świadome wywoływanie objawów cielesnych) + in vivo. Często trudniejsze.

02 ? Pułapki diagnostyczne — co to *nie jest* fobia specyficzna

AKROFOBIA CZY MYŚL NATRĘTNA?

„Co jeśli skoczę z balkonu?” — jeśli myśl jest natrętna i niechciana, to nie fobia, tylko zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD). Inny protokół.

KLAUSTROFOBIA CZY LĘK PANIKI?

Jeśli lęk dotyczy *ataku paniki* w windzie (a nie samej windy), to zaburzenie paniczne z agorafobią. Wymaga ekspozycji interoceptywnej.

EMETOFOBIA CZY ZABURZENIE ODŻYWIANIA?

Lęk wymiotów współwystępuje z anoreksją w >30% przypadków. Pierwszeństwo: leczenie zaburzenia odżywiania.

FOBIA SPOŁECZNA ≠ SPECYFICZNA

Lęk przed wystąpieniem publicznym, jedzeniem przy ludziach — to zaburzenie lęku społecznego, nie fobia specyficzna. Inny protokół.

03 ✎ Mój przypadek — rozpoznaj swój typ

CZEGO KONKRETNIE SIĘ BOJĘ — PEŁNA LISTA OBIEKTÓW LUB SYTUACJI

MÓJ TYP WG DSM-5

PIERWSZA LINIA LECZENIA DLA TEGO TYPU

CZY W MOIM PRZYPADKU JEST MIESZANKA TYPÓW LUB WSPÓŁWYSTĘPUJĄ INNE ZABURZENIA?

04 ☉ Co zabrać do rozmowy z terapeutą

Konkretne pytanie: jaki typ fobii według DSM-5 mam i jaki jest *specyficzny* protokół dla tego typu? Czy są techniki, których nie powinienem/-am stosować (np. relaksacji przy BII)?

Lista współistniejących lęków: czy mam atak paniki, lęk uogólniony, depresję, OCD? To wpływa na kolejność leczenia — nie zawsze fobia jest pierwsza w kolejce.

Klucz: Pięć typów fobii to **pięć różnych ścieżek leczenia**. Fobia BII bez napinania mięśni to ryzyko omdlenia. Klaustrofobia leczona jak fobia zwierzęca — długie miesiące bez postępu. Dobrze postawiona diagnoza typu daje 20–30% różnicy w skuteczności (Choy i wsp. 2007). Jeśli leczenie nie działa po 5–6 sesjach, warto wrócić do podstaw: czy to na pewno fobia specyficzna i czy to na pewno ten typ?